Rete per l'umanizzazione, rete di prossimità. Una inchiesta sui *bisogni di salute*

a cura di
Anthony Candiello
e Olmo Tarantino
membri esperti della Consulta

Con la Riforma Sanitaria del 1978 (legge 833 del 23/12/'78) l'attenzione ai problemi della salute non è più una questione riservata agli "addetti ai lavori", ma viene riconosciuta come una questione di interesse dell'intera comunità, della quale si richiede la partecipazione attiva.
La "socializzazione" del problema della salute e della malattia, la dilatazione delle strutture e dei servizi, le finalità preventivo-educative e non soltanto diagnostico-curative implicite nel concetto di ***tutela della salute****, fanno della questione salute una componente "normale" della vita delle persone, per cui è necessario rendere consapevoli i cittadini e, dunque, responsabili della propria e altrui salute. In una parola i cittadini da "consumatori passivi" dei servizi sanitari, devono divenire "attori corresponsabili" del bene comunitario che è la "salute", intesa non più come semplice assenza di malattia, ma come "****una condizione di armonico equilibrio fisico e psichico della persona, dinamicamente integrato nel proprio ambiente naturale e sociale****".*

D'altra parte anche ad un sommario esame della situazione sociale e ambientale ci si accorge che, se si vogliono ottenere risultati nella medicina preventiva, nel suo momento territoriale, è necessario fare appello alla corresponsabilità dei cittadini e dare spazio alla loro partecipazione. Peraltro il termine "socializzazione" che caratterizza il modello di riforma sanitaria italiana sarebbe parola vuota se non volesse dire partecipazione sociale in senso attivo e non soltanto in senso beneficiario e consumistico.

Con la partecipazione attiva dei cittadini, giorno dopo giorno, iniziativa dopo iniziativa, si costruisce un "ponte" di comunicazione fra i cittadini e le istituzioni sui temi della salute. In questa prospettiva preziosa è l'opera di mediazione delle associazioni, quali corpi intermedi dello Stato e volontari nella società pluralista al fine di trasmettere impulsi e valori, dando altresì a ciascun uomo la possibilità di essere informato e di esprimersi e impegnandolo quindi in una responsabilità comune.

Compiti della Consulta e raccomandazioni del Sindaco

Questi concetti sono stati bene espressi dal Sindaco di Venezia allorché è stata insediata la Consulta per la Tutela della Salute che tra i vari compiti, previsti dal suo Regolamento, annovera:
Incentivare la più ampia e reale partecipazione dei cittadini intorno ai temi della salute:

- Individuare i bisogni di salute del territorio e proporre soluzioni all'Autorità comunale competente;
- Sviluppare la capacità di comprendere il valore della salute come bene comune: conoscenza, educazione alla salute, rendere consapevoli le coscienze;
- Facilitare la comunicazione ed il coordinamento tra le realtà che a vario titolo si occupano di problematiche della salute.

Per quanto riguarda il compito di "**individuare i bisogni di salute del territorio**", il Sindaco, rivolgendosi alle associazioni, è stato estremamente esplicito: "*dovete essere delle antenne, dei sensori nel territorio per captare, rilevare i bisogni di salute, poiché l'Amministrazione non può essere onnipresente*".

Una indagine conoscitiva tra le associazioni per meglio conoscere i bisogni

Da qui è nata l'dea di un'**indagine conoscitiva sui bisogni per una migliore qualità di vita e di salute**, attuata attraverso una verifica della

reale corrispondenza, per qualità e quantità dei servizi per la "tutela della salute" del territorio del Comune di Venezia, rispetto ai bisogni di salute e alla aspettative della gente.
Funzionali a tale indagine sono le "**schede di lavoro"** consegnate nell'autunno 2009 a tutte le associazioni – sia a quelle di servizio che a quelle di volontariato - partecipanti alla Consulta per la Tutela della Salute del Comune di Venezia.
Ogni associazione, prendendo in esame specificatamente l'area di proprio interesse, ed in base all'esperienza maturata nell'assistere i propri associati, potrà esprimere la propria valutazione sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi erogati nel territorio di sua conoscenza, le criticità, i miglioramenti proposti (qualità), i servizi mancanti (quantità), le proposte per il futuro affinché i servizi siano sempre più aderenti ai bisogni del cittadino, soprattutto di quelli non in piena salute. In una parola le associazione vengono invitate ad essere "voce di chi non ha voce".
Per agevolare le associazioni nella risposta alla "**griglia di domande**" preordinate, in ciascuna "**scheda di lavoro**" sono state riportate alcune informazioni di riferimento. E, poiché alcune problematiche riguardano più aree tra loro interconnesse, le associazioni che lo vorranno potranno compilare più di una scheda, onde più compiutamente esprimere le proprie osservazioni e le proprie proposte.
Le analisi, le proposte, le criticità puntualmente riscontrate e riportate nelle risposte finora pervenute, oltre a confermare la validità dell'iniziativa, ci hanno indotto a qualche ulteriore precisazione nelle schede di riferimento, ed a prolungare fino a maggio 2010 la consegna dei dati, onde poi completarne l'elaborazione entro il mese di giugno 2010.

Per una rete di assistenza che sia umana

Significativo il titolo che si è voluto dare all'indagine conoscitiva: "**Rete per l'umanizzazione o rete di prossimità".** Con tale connotazione si è voluto sottolineare che oggigiorno si potranno ottenere risultati sinergici efficaci nell'affrontare i bisogni di assistenza del cittadino se si uniranno in qualche modo le forze – facendo "sistema" come ha più volte raccomandato il Sindaco -, in fattiva collaborazione tra l'Ente pubblico che deve sostenere la famiglia, l'unità della famiglia e la dignità del cittadino-persona in tutti i momenti e le circostanze di vita, soprattutto in quelli più difficili come nella malattia, nella disabilità, nel disagio.
Una "**rete di prossimità**" fatta non solo di associazioni, ma anche di persone, famiglie, piccole comunità, imprese profittevoli e non, volontariato, cooperative, che alimenta il senso di responsabilità civile, la fiducia e

la solidarietà reciproca. Sono questi i luoghi in cui la dinamica delle relazioni aiuta ciascuna persona a crescere e a maturare coscienza di sé e delle proprie potenzialità. (*)
Si è voluto altresì sottolineare la qualità dell'assistenza che deve essere **umana** e **umanizzante** nel prendersi cura della persona nella sua globalità psico-fisica, relazionale, sociale e spirituale secondo dei principi che vengono presentati come modello specifico di riferimento per ogni singola scheda. Le coordinate di quest'ultime furono proposte con il Convegno "**La sfida dell'umanizzazione per la promozione e la tutela della salute** " - programmato dalla Consulta e svolto il 19 maggio 2007 – da cui è scaturito l'invito a ***riscoprire il senso più vero e l'esigenza più impegnativa della centralità dell'uomo, ogni volta che si parla di salute e di sofferenza***. (**)

Maggiore umanità per vincere la solitudine esistenziale

Parlare di "**centralità dell'essere umano**" **significa attenzione ai suoi bisogni fondamentali** tra i quali emergono il **bisogno di sicurezza, di appartenenza e di affetto, di autorealizzazione**, implicitamente presenti, quasi in "filigrana", nelle schede di riferimento per ogni singola area.
Un tipico esempio di questi bisogni emergenti lo si riscontra nella "***solitudine esistenziale***", generata da una idea di libertà assoluta, svicolata da ogni legame, identificata nella possibilità di attuare qualunque scelta purché ipotizzabile. Ciò ha condotto le persone a sperimentare la vertigine di una "solitudine esistenziale" sempre più isolante. Alla incapacità di aderire alla realtà è conseguita una maggiore fragilità esistenziale e morale. Un individuo isolato e inerme di fronte alla realtà è l'esito ultimo di un certo nichilismo moderno, che può sfociare, talora, nel suicidio.
Le società intermedie, quali sono le associazioni e tutte le altre forme di "cittadinanza attiva", costituiscono un antidoto a questa deriva, collaborando con le istituzioni alla realizzazione di una "**rete per l'umanizzazione o rete di prossimità**", che incarna un principio sociale in grado di originare un ***Welfare comunitario.***

Le schede di lavoro fornite alle associazioni

Sono state così prese in esame otto aree, e cioè l'area **minori, giovani, anziani, salute mentale, disabilità, disagio sociale, immigrazione, ambiente**.
Principio guida unitario di riferimento per tutte le "**schede di lavoro**" è stato il concetto di salute già rammentato: ***"la salute è una condizione di armonico equilibrio fisico e psichico della persona, dinamicamente integrato nel proprio ambiente naturale e sociale***"

Mentre le prime sette schede fanno riferimento ai vari ambienti sociali di vita secondo l'età delle persone e lo stato di salute, l'ottava scheda fa riferimento all'ambiente naturale, all'ambiente ecologico.
In Italia lentamente matura una sensibilità individuale e collettiva per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, dei mari. Tuttavia molta strada deve essere ancora percorsa se si vogliamo rendere le città meno inquinate (smog da emissione di fumi industriali, da riscaldamento delle abitazioni, da autoveicoli circolanti, da onde elettromagnetiche, ecc.) e più vivibili, soprattutto per i riflessi negativi sulla salute. (***)
Ma per ambiente ecologico non si deve intendere soltanto l'aria che respiriamo, le piante che sono necessarie e il verde che deve rimanere nelle città, i cibi che mangiamo e le acque che consumiamo e beviamo, ma anche il clima psicologico, il clima culturale e morale: l'inquinamento può ledere il bene della persona più profondamente sul piano dei mezzi di comunicazione che nell'eventuale scarico di un mefitico collettore di liquami.

L'educazione alla responsabilità

È su questo terreno che ci si accorge come non sia possibile fare a meno di una ***responsabilità*** e di una ***educazione alla responsabilità***, non solo del singolo, ma della comunità intera, non solo sul piano sociale e volontaristico, ma anche sul piano politico e della legislazione.
L'educazione alla responsabilità e alla salute rientrano in quell' "**emergenza educativa**" di cui da tempo voci autorevolissime ne sollecitano adeguati interventi risolutivi. Le varie agenzie educative, tra le quali le associazioni, non possono sottrarsi a questo ineludibile impegno nell'interesse di tutti e di ciascuno.
Nelle **sintesi** per ciascuna area delle "schede di lavoro" (minori, giovani, anziani, ecc.) verranno espressamente citate, quale bell'esempio di partecipazione responsabile, di "cittadinanza attiva" che vuole fare "sistema", le associazioni che avranno intelligentemente collaborato per ogni singola area.

(*) (**) Alcuni concetti riguardanti l'**Umanizzazione** dei **servizi sanitari, socio-sanitari, sociali** e la "**rete per l'umanizzazione o rete di prossimità**" sono riportati nella sesta sezione di questo Quaderno nel documento "**Qualità e umanizzazione: un binomio inscindibile per la cura della persona"** a cura del dott. Olmo Tarantino.
(***) Si veda in proposito la relazione del dott. Anthony Candiello: "**Inquinamento e danni alla salute**. **Un cambiamento è urgente nel nostro modello di vita**", riportata nella sesta sezione di questo Quaderno.

SEZIONE 1

ANALISI DELLE SCHEDE

SCHEDA DI LAVORO N. 1: MINORI

L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha proclamato il 2009 "***Anno internazionale del fanciullo".*** Prendendo spunto e analizzando la "***Dichiarazione dei diritti del fanciullo***", votata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 febbraio 1959, dovrebbe emergere quali politiche socio-sanitarie vogliamo adottare nel nostro territorio in favore dei bambini e degli adolescenti.
Dal documento risulta che l'orientamento di fondo delle istituzioni ed associazioni dovrebbe essere quello di accompagnare i bambini e gli adolescenti nel proprio percorso evolutivo, in modo sussidiario rispetto alle famiglie. In un'ottica di lavoro di comunità, perseguendo obiettivi di tipo educativo, promozionale, preventivo, di sostegno alla partecipazione ed ai diritti con particolare attenzione alla:

- Centralità del bambino portatore di un'identità e consapevolezza di sé, fonte di diritti, membro di una famiglia e quindi di una cultura di provenienza;
- Il bambino va posto nella condizione di soggetto attivo con diritto alla "conoscenza" e alla "creatività", per favorirne l'integrazione relativamente all'età, ceto sociale, sesso ed etnia;
- Centralità della famiglia attraverso una relazione significativa per permettere la sua partecipazione attiva al progetto educativo.

I ***principi*** che sostengono le politiche dei servizi erogati alla prima infanzia dovrebbero essere i seguenti:

- I servizi all'infanzia devono essere servizi educativi e sociali di interesse pubblico;
- Per i bambini, i servizi devono essere luogo di formazione, di socializzazione e di stimolo alle loro potenzialità cognitive, affettive, individuali e sociali nella prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo;
- Per le famiglie, i servizi devono essere di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro, in un quadro di pari opportunità per entrambi i genitori;
- Con la partecipazione delle famiglie si deve realizzare la gestione di comunità: attraverso la promozione di iniziative che le coinvolgano

nella progettazione educativa e concorrono ad elaborare nuove linee di sviluppo dei servizi.

Verifica: **dalla mappa dei servizi pubblici, convenzionati e non convenzionati per l'infanzia nel nostro territorio e dal loro funzionamento, in base alle informazioni raccolte dalle famiglie e dalle associazioni, essi corrispondono e assolvono efficacemente ai compiti loro assegnati? Quali i punti di forza? Quali le criticità? Di quali servizi nuovi le famiglie necessiterebbero?**

SCHEDA DI LAVORO N. 2: GIOVANI

L'orientamento di fondo che dovrebbe sostenere le politiche rivolte ai giovani, in un'ottica di crescita della persona, dovrebbe essere il seguente:

- Contribuire al miglioramento della *qualità* della vita dei giovani e delle loro famiglie;
- Promuovere azioni di sensibilizzazione nei confronti delle tematiche dei maltrattamenti e dell'abuso dei bambini e degli adolescenti e gestire interventi di protezione/tutela;
- Sostegno ed accompagnamento nel far fronte ai propri compiti evolutivi;
- Lavorare in rete con gli adulti che a vario titolo si occupano di giovani, svolgendo la funzione di connettori sociali e di facilitatori dell'incontro tra le generazioni.

I ***principi*** che dovrebbero ispirare e sostenere le politiche dei servizi erogati a favore dei giovani dovrebbero essere i seguenti:

- Centralità e dignità della persona e della famiglia;
- Giustizia sociale, solidarietà e fraternità;
- Centralità della relazione educativa;
- Promozione integrale della persona, del valore della vita, dei valori condivisi (pace, rispetto della vita, interesse all'altro, solidarietà) e del senso etico dell'esistenza;
- Aiuto all'esplicitazione e all'elaborazione della domanda di educazione, spesso inespressa o espressa in forma implicita dai giovani;
- Co-educazione (ci si educa insieme);
- Orientamento alle scelte, ai valori, alla progettualità;
- Sostegno ed accompagnamento nel far fronte ai propri compiti evolutivi.

Verifica: **dalle informazioni raccolte attraverso famiglie ed associazioni nel nostro territorio quali servizi esistono per i giovani che si ispirano ai principi sopra enumerati? Esistono servizi di eccellenza e quali? Quali le criticità? Quali miglioramenti proporre?**
La verifica comporta anche la risposta ai seguenti quattro interrogativi: si svolgono

- Attività di formazione con gli adulti, incontri genitori/figli e laboratori nelle scuole?
- Attività educativa territoriale rivolta a: 1) giovani appartenenti a nuclei familiari multiproblematici? 2) alla prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili attraverso i consultori? 3) viene impartita un'educazione alla salute, in particolare un'educazione sessuale?
- Interventi di prevenzione del disagio e laboratori nelle scuole e con le famiglie?
- Attività di prevenzione dell'uso delle sostanze psico-attive nelle scuole, nel territorio, nel locali pubblici, onde evitare le dipendenze?

SCHEDA DI LAVORO N. 3: ANZIANI

Le azioni svolte per la popolazione anziana residente sul territorio dovrebbero avere come obiettivo il miglioramento della *qualità* di vita degli anziani, a cui sono rivolti servizi di animazione e di assistenza di base, svolti sia al loro domicilio che in strutture residenziali e simiresidenziali.
Il settore della terza età come viene curato nel nostro territorio?

Lo stile ed il pensiero fondanti la gran parte delle attività delle istituzioni, cooperative, associazioni dovrebbero essere ispirati alle idee:

- Dell'invecchiamento come processo naturale, e non come elemento di diversità o di malattia, che si sviluppa in modo differenziato secondo i contesti sociali, culturali e familiari nei quali esso avviene;
- Del sostegno alla domiciliarità, in quanto si ritiene che il rimanere più a lungo possibile in famiglia e all'interno della propria casa rappresenti, per l'anziano, la condizione più appropriata per il rispetto della sua dignità, delle sue abitudini e del suo vissuto, in qualsiasi condizione esso si trovi di autosufficienza o non autosufficienza, di autonomia fisica e cognitiva e di disabilità psicologica, fisica e mentale. Inoltre, facendo leva sul radicamento nel territorio, si deve cercare di promuovere il benessere sociale e la vita relazionale tra i cittadini, stimolando e orga-

nizzando la partecipazione e la responsabilità dei singoli e dei gruppi;
- Della centralità della famiglia e del lavoro con la famiglia;
- Della collaborazione con i vari soggetti della rete dei servizi sociali ed istituzionali della comunità locale, per costruire e fortificare il sostegno alla persona e alla famiglia.

Verifica: **dalle informazioni raccolte attraverso famiglie ed associazioni quanto è stato fatto per realizzare queste idee nel nostro territori? Esistono servizi di eccellenza? Quali le criticità? Quali le proposte da raccomandare alle istituzioni?**

SCHEDA DI LAVORO N. 4: SALUTE MENTALE

L'azione da svolgere in area "salute mentale" dovrebbe rispondere all'obiettivo di accrescere nella comunità locale le opportunità di emancipazione e di recupero di cittadinanza per le persone con disagio psichico e per i loro familiari.
Questa crescita di opportunità dovrebbe avvenire sviluppando una "rete di interventi" tra di loro integrati, sinergici e complementari, in modo da offrire risposte diversificate, personalizzate, flessibili e dinamiche. Così i servizi risulterebbero strutturati in "filiera", come risposta integrata ai diversi problemi delle persone e alla loro evoluzione, con interventi riabilitativi psichiatrici che vanno dalla residenzialità protetta all'autonomia, dalla semi-residenzialità all'inserimento lavorativo, dalle attività di tempo libero allo sviluppo di rete sociale.
Nell'ottica dell'impresa sociale di comunità, tale rete integrata di interventi dovrebbe favorire e promuovere l'emancipazione e l'evoluzione delle persona: l'articolazione in sequenza di più segmenti di percorsi socio-riabilitativi integrati (residenzialità, semi-residenzialità, formazione al lavoro, sviluppo di reti sociali) offrendo la possibilità di progettare e realizzare effettivi percorsi mirati alla completa emancipazione ed autonomia del soggetto, fino alla sua fuoriuscita dal circuito dei Servizi.

I ***valori*** ed i ***principi*** di riferimento nelle politiche di promozione della salute mentale e negli intervento socio-riabilitativi e di inclusione sociale delle persone con disagio psichico, sono i seguenti:
- centralità della persona: mettere al centro la persona intesa nella sua globalità e non ridotta alla sola parte "malata", promuovendone i diritti e restituendole potere al fine di essere parte attiva della collet-

tività; la persona (cittadino, utente, familiare, operatore) è soggetto attivo del proprio percorso evolutivo e non soggetto passivo di interventi; gli utenti vengono coinvolti e resi protagonisti nel loro percorso riabilitativo.

- **Appartenenza alla città:** vivere la città come luogo da cui nessuno è escluso ed in cui tutti vengono chiamati a partecipare. Le associazioni e le cooperative che se ne occupano appartengono alla città ed agiscono affinché ognuno sia considerato parte di essa.
- **Salute mentale:** promuovere salute mentale come patrimonio dell'intera collettività, che non si limita agli interventi psichiatrici (cura e riabilitazione), ma comprende azioni di promozione culturale e sensibilizzazione;
- **Cambiamento:** agire il cambiamento, a livello individuale e sociale, come percorso in cui le persone diventano soggetti attivi della propria emancipazione, come mutamento delle aspettative, della cultura e delle regole del contesto, atto al reinserimento delle persone con piene opportunità e diritti.
- **Cultura dell'accoglienza:** sviluppare cultura della diversità intesa come risorse da includere e non come limiti da escludere.
- **Cittadinanza attiva:** sviluppare l'impresa sociale cooperativa come esperienza di partecipazione attiva dei cittadini nella costruzione di risposte ai loro bisogni sociali, aggregare a questo scopo molteplici portatori di interessi intorno all'obiettivo della promozione della salute mentale (operatori professionali, utenti, familiari, cittadini, istituzioni, imprese).

Verifica: le nostre realtà istituzionali, associative, cooperative si ispirano a questi valori ed a questi principi? È possibile una mappa dell'esistente per il recupero della salute mentale (servizi residenziali, semiresidenziali, di prossimità, associazioni, cooperative)? Quale il loro funzionamento? Quali le criticità? Cosa migliorare? Cosa dovrebbero fare le istituzioni?

Gli obiettivi generali dei "programmi riabilitativi individualizzati" dovrebbero essere i seguenti:

- Promozione del protagonismo sociale della persona in ogni percorso di vita.
- **Servizi per il miglioramento della salute mentale:** si ricerca, laddove è possibile, il coinvolgimento della singola persona nel suo programma riabilitativo individuale e, nell'ambito degli interventi relativi alla salute mentale, il coinvolgimento ha come obiettivo quello di aumentare la

consapevolezza individuale relativa al proprio disturbo ed acquisire competenze per aumentare la propria capacità di gestirlo.

- **Recupero e sviluppo di abilità sociali:** per abilità sociali si intendono tutte le abilità necessarie ad avere scambi significativi con il contesto di riferimento in cui le persone vivono. Sono abilità che consentono ad ogni persona di avere scambi relazionali con altri, fare acquisti, partecipare ad attività di gruppo, gestire il proprio denaro, consentono cioè la costruzione di una identità sociale che permette al soggetto di condividere con altri esperienze ed attività.
- **Acquisizione di autonomie personali:** le autonomie personali sono le capacità della persona di prendersi cura di sé, dei propri oggetti e del proprio spazio di vita, di prepararsi il cibo e di collaborare alle attività domestiche. Le attività assistenziali e socio-riabilitative sono orientate a consentire al soggetto di rendersi maggiormente autonomo nel percorso di emancipazione di sé.

Verifica: i "programmi riabilitativi" dei nostri servizi sono *individuali*? si propongono di raggiungere questi obiettivi? Quali servizi del ns. territorio perseguono meglio il raggiungimento di questi obiettivi? Quali servizi presentano forti criticità? Cosa proporre alle istituzioni?

SCHEDA DI LAVORO N. 5: DISAGIO SOCIALE

Occuparsi del disagio delle persone adulte significa intervenire su quella fascia di popolazione che va dai 18 ai 64 anni e che presenta vari tipi di problematiche che rendono difficile l'integrazione socio-lavorativa. Non si tratta, quindi, di persone portatrici di patologie psichiche certificate o di disabilità psicofisica, quanto piuttosto di adulti socialmente svantaggiati per le cause più differenti, e che solitamente presentano alcune delle seguenti caratteristiche:

- Periodi di carcerazione più o meno lunghi;
- Esperienze di tossicodipendenza o alcol dipendenza;
- Assenza dei diritti minimi di cittadinanza (stranieri irregolari);
- Un ambito relazionale di forte disagio, di esclusione o autoesclusione;
- Scarse o nulle competenze tecniche lavorative, comunque poco spendibili sul mercato;
- Incapacità a svolgere le funzioni minime genitoriali, in caso di presenza di minori.

Per tutti, il lavoro degli operatori dovrebbe riguardare il *piano dell'identità* nei suoi tre aspetti: affettiva, sociale e lavorativa. In questo senso è fondamentale lavorare con la persona differenziando l'intervento a seconda dei "luoghi" in cui si trova: l'ambito residenziale si concentra sulla dimensione affettiva con incursioni nella sfera sociale. L'ambito di inserimento lavorativo in ambiente protetto fornisce ulteriori strumenti di osservazione e di acquisizione di consapevolezza sulle abilità e sulle aree di miglioramento di ciascuno. Per semplificare, si possono distinguere tre macroaree di intervento differenziato, che tuttavia sono spesso intrecciate tra loro nei casi che si presentano.

- **Carcere:** Chi vive una lunga istituzionalizzazione ha spesso difficoltà a leggere la realtà esterna, per cui a un forte desiderio di riscatto fa da contrasto una scarsa capacità di assumersi le responsabilità della vita, dovuta a carenza di risorse, a paura, a isolamento. Sul piano sociale spesso viene vissuta la frustrazione del ruolo importante che si aveva nell'ambiente criminale rispetto al ruolo attuale di emarginazione. La popolazione detenuta ha bassissimo livello culturale e spesso nessuna esperienza lavorativa precedente alla carcerazione.
- **Tossicodipendenza:** Nella fase di reinserimento della persona ex tossicodipendente il primo momento critico è l'abbandono della vita comunitaria, che ha contribuito a ristabilire un equilibrio (a volte precario) nell'identità complessiva dell'individuo. È importante che la fase post-comunità sia ancora tutelata, sia nell'ambito relazionale che in quello lavorativo, per favorire l'acquisizione di strumenti nuovi.
- **Nuove povertà:** Il segnale che la persona sta lentamente degradando può venire dalla perdita del lavoro e/o di forti legami affettivi. La caratteristica principale delle cosiddette "nuove povertà" è proprio il riconoscimento sociale pubblico, che porta persone assolutamente integrate a mettere in atto meccanismi di autoesclusione. In molti casi il disagio sociale è accompagnato dallo sviluppo di una patologia psichiatrica non evidenziata in precedenza. Non avendo lunghi percorsi nei servizi sociali, è molto difficile creare alleanza sia in ambito relazionale che lavorativo

Verifica: Come si opera in quest'area da parte dei servizi? Attraverso quali attività? Svolte da chi? Come è strutturato l'intervento degli operatori? Come intervengono le associazioni? Quali le criticità? Cosa proporre alle istituzioni?

SCHEDA DI LAVORO N. 6: DISABILITÀ

La classificazione ICDH (*International Classification of Disabilities and Handicaps*) del 1980 dell'**Organizzazione mondiale della sanità** (OMS) distingueva tra:

- **menomazione** intesa come perdita a carico di funzioni fisiche o psichiche, e rappresenta l'estensione di uno stato patologico. Se tale disfunzione è congenita si parla di **minorazione**;
- **disabilità**, ovvero qualsiasi limitazione della capacità di agire, naturale conseguenza ad uno stato di minorazione/menomazione;
- **handicap**, svantaggio vissuto da una persona a seguito di disabilità o minorazione/ /menomazione.

A cura dell'O.M.S. una nuova classificazione è subentrata all'ICDH il 21 maggio 2001 quale nuovo standard di classificazione dello stato di malattia e di salute.
La nuova classificazione, detta ICF (International Classification of Functioning) o *Classificazione dello stato di salute*, definisce lo stato di salute delle persone piuttosto che le limitazioni, dichiarando che l'individuo "sano" si identifica come "individuo in stato di benessere psicofisico" ribaltando, di fatto la concezione di stato di salute. Introduce inoltre una classificazione dei fattori ambientali.

Il concetto di disabilità cambia e secondo la nuova classificazione (approvata da quasi tutte le nazioni afferenti all'ONU) e diventa un **termine ombrello** che identifica le difficoltà di funzionamento della persona sia a livello personale che nella partecipazione sociale. In questa classificazione i fattori biomedici e patologici non sono gli unici presi in considerazione, ma si considera anche l'interazione sociale: l'approccio, così, diventa multiprospettico: biologico, personale, sociale. La stessa terminologia usata è indice di questo cambiamento di prospettiva, in quanto ai termini di menomazione, disabilità ed handicap (che attestavano un approccio essenzialmente medicalista) si sostituiscono i termini di Strutture Corporee, Attività e Partecipazione. Di fatto lo standard diventa più complesso, in quanto si considerano anche i fattori sociali, e non più solo quelli organici.

Funzioni corporee

1. Funzioni mentali
2. Funzioni sensoriali e dolore
3. Funzioni della voce e dell'eloquio
4. Funzioni dei sistemi cardiovascolare, ematologico, immunologico, respiratorio

5. Funzioni dell'apparato digerente e dei sistemi metabolico ed endocrino
6. Funzioni riproduttive e genitourinarie
7. Funzioni neuro - muscolo - scheletriche correlate al movimento
8. Funzioni cutanee e delle strutture correlate

Strutture corporee

1. Sistema nervoso
2. Visione e udito
3. Comunicazione verbale
4. Sistemi cardiovascolare e immunologico, apparato respiratorio
5. Apparato digerente e sistemi metabolico ed endocrino
6. Sistemi genitourinario e riproduttivo
7. Movimento
8. Cute e strutture correlate

Fattori ambientali

1. Prodotti e tecnologia
2. Ambiente naturale e cambiamenti effettuati dall'uomo
3. Relazione e sostegno sociale
4. Atteggiamenti
5. Sistemi, servizi e politiche

Attività e partecipazione

1. Apprendimento ed applicazione delle conoscenze
2. Compiti e richieste generali
3. Comunicazione
4. Mobilità
5. Cura della propria persona
6. Vita domestica
7. Interazione e relazioni personali
8. Aree di vita principali
9. Vita sociale, civile e di comunità

L'azione da svolgere in area "disabilità", molto vasta e differenziata, dovrebbe rispondere all'obiettivo di accrescere nella comunità locale le opportunità di emancipazione e di recupero di cittadinanza per le persone con diversi tipi di disabilità e per i loro familiari.
Questa crescita di opportunità dovrebbe avvenire sviluppando una "rete di interventi" tra di loro integrati, sinergici e complementari, in modo da offrire risposte diversificate, personalizzate, flessibili e dinamiche. Così i

servizi risulterebbero strutturati in "filiera", come risposta integrata ai diversi problemi delle persone e alla loro evoluzione, seguendo progetti riabilitativi personalizzati ed un programma attuativo e di verifica del progetto, elaborato in collaborazione con la famiglia.
In quest'area è importante lavorare con le scuole (nidi, elementari, medie inferiori, medie superiori), offrendo servizi di appoggio scolastico ed interventi educativo-assistenziali per l'integrazione scolastica ed extra-scolastica di minori diversamente abili, con l'obiettivo di facilitare l'autonomia e garantire condizioni di pari opportunità con gli altri bambini e ragazzi.
È inoltre importante occuparsi dell'integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro.
Le diverse specializzazioni delle cooperative devono permettere di offrire diverse opportunità: le attività richiedono abilità differenti e, in questo modo, è possibile rispondere a più tipi di disagio. Il lavoro inoltre dà alle persone inserite la possibilità di acquisire nuove competenze che aprono a molti, o dovrebbero aprire (siamo in piena crisi economico-finanzaria) le porte del mondo del lavoro non protetto.
Nel nostro territorio vi sono parecchie associazioni, cooperative che si occupano di persone con disabilità.

I ***valori*** ed i ***principi*** di riferimento nelle politiche di promozione della salute e negli intervento socio-riabilitativi e di inclusione sociale delle persone con disabilità, in linea generale sono i seguenti:

1. centralità della persona: mettere al centro la persona intesa nella sua globalità e non ridotta alla sola parte "malata", promuovendone i diritti e restituendole potere al fine di essere parte attiva della collettività; la persona (cittadino, utente, familiare, operatore) è soggetto attivo del proprio percorso evolutivo e non soggetto passivo di interventi; gli utenti vengono coinvolti e resi protagonisti nel loro percorso riabilitativo.
2. Appartenenza alla città: vivere la città come luogo da cui nessuno è escluso ed in cui tutti vengono chiamati a partecipare. Le associazioni e le cooperative che se ne occupano appartengono alla città ed agiscono affinché ognuno sia considerato parte di essa.
3. Cambiamento: agire il cambiamento, a livello individuale e sociale, come percorso in cui le persone diventano soggetti attivi della propria emancipazione, come mutamento delle aspettative, della cultura e delle regole del contesto, atto al reinserimento delle persone con piene opportunità e diritti.

4. Cultura dell'accoglienza: sviluppare cultura della diversità intesa come risorse da includere e non come limiti da escludere.
5. Cittadinanza attiva: sviluppare l'impresa sociale cooperativa come esperienza di partecipazione attiva dei cittadini nella costruzione di risposte ai loro bisogni sociali, aggregare a questo scopo molteplici portatori di interessi intorno all'obiettivo della promozione della salute (operatori professionali, utenti, familiari, cittadini, istituzioni, imprese).

Verifica:
- **Le realtà istituzionali, cooperative, associative si ispirano ai valori e ai principi esposti in questa "scheda di lavoro"?**
- **nel nostro territorio i servizi, le associazioni, le cooperative cosa chiedono alle istituzioni per poter migliorare la *qualità* del servizio e ottenere migliori risultati?**

SCHEDA DI LAVORO N. 7: IMMIGRAZIONE

Quest'area sta acquistando sempre maggiore importanza, data la necessità di offrire risposte ai bisogni del nostro territorio che vede un trend in crescita della immigrazione
Esistono diverse tipologie di servizi. In particolare sportelli informativi per immigrati.
I servizi, grazie al lavoro di mediatori/mediatrici culturali, permetto nodi incontrare ogni anno migliaia di cittadini stranieri, ma anche cittadini italiani che hanno relazioni di tipo familiare, amicale o lavorativo con persone immigrate nel nostro territorio.
Scopo principale degli sportelli informativi è quello di favorire l'inserimento nel tessuto sociale e la conquista dell'autonomia, attraverso l'informazione e l'accompagnamento, in rete con i servizi del territorio.
Negli sportelli informativi la mediazione culturale è offerta o dovrebbe essere offerta in lingua italiana, francese, inglese, araba, albanese, romena (altre lingue su richiesta).

Verifica: **con l'entrata in vigore della recente legge sulla "sicurezza", quali nuove problematiche si aprono? Che cosa proporre alle istituzioni? Come venire incontro ai bisogni degli immigrati?**

SCHEDA DI LAVORO N. 8: AMBIENTE

L'area veneziana ospita un sito di produzioni **chimiche ed industriali** tra i maggiori e **più impattanti in Europa**, affiancato da una consistente densità di impianti di **produzione di energia elettrica** da combustibili, con il loro carico emissivo. Le produzioni industriali sono inoltre affiancate da grandi **flussi di traffico** multimodale: le **navi** che transitano nella laguna veneziana sono **grandi** ed **inquinanti**, per via del combustibile ad alto tenore di zolfo; un numero elevatissimo di **mezzi pesanti** (oltre che leggeri) attraversano quotidianamente la tangenziale di Mestre. **Volumi** immessi, **numerosità** delle sorgenti, **ampiezza** dello spettro di inquinanti, **eredità** pregresse depositate nei suoli e nelle acque, impatto di trasporti e **logistica** sono tali da indicare come **sostanzialmente unico** il "caso" veneziano.

La violenza dell'impatto ambientale perpetrato in decenni di sistematica immissione di ogni forma di inquinanti in tutte le matrici ambientali si è peraltro manifestata in uno degli ecosistemi **più fragili** e *meno in grado* di contenere le dispersioni degli inquinanti, quello lagunare. La criticità del sistema è infatti **ulteriormente amplificata** dalle caratteristiche geomorfologiche, tra le quali citiamo:

a) il peculiare sistema lagunare di interconnessioni idriche sotterranee che rende praticamente **impossibile** il **contenimento** della diffusione degli inquinanti via *suoli*, *acqua* e *sedimenti*, che spesso entrano a contaminare le catene alimentari
b) la specifica conformazione chiusa della pianura padana, che **impedisce** il rimescolamento e la diluizione degli inquinanti immessi in aria e rende tale territorio **tra i più inquinati del pianeta** e mette a dura prova i polmoni dei cittadini veneziani.

La **combinazione dei due fattori** impone quindi una particolare attenzione agli effetti di questo fenomeno sulla nostra **salute**.

Le **politiche** rivolte ad un atteggiamento più efficace volto a **contenere** l'*impatto sull'ambiente* ed a **ridurre** gli *effetti potenziali sulla salute dei cittadini veneziani* dovrebbero intervenire come segue:

- **finanziare** studi e ricerche di ordine **epidemiologico** (per *misurare* gli effetti sulla salute dei fattori ambientali ed assimilabili) e di ordine **tossicologico** (per *attestare scientificamente* la correlazione tra fattori ambientali e patologie);
- **sostenere** percorsi di studio ed analisi basati sulla **prevenzione**, più che sulla cura "ex post", di patologie di cui è nota la relazione causa-effetto con fattori ambientali nocivi che possiamo almeno in parte controllare;

- intervenire a **riduzione** delle quantità e delle qualità delle **immissioni inquinanti** di origine **antropica** *industriale ed urbana*, favorendo l'evoluzione verso **processi più avanzati** a minore impatto ambientale e sanitario;
- migliorare le **condizioni lavorative** presenti in alcuni comparti dove i lavoratori sono tuttora soggetti ancora a notevoli **rischi** sanitari per esposizione diretta agli inquinanti;
- favorire una crescita culturale per una più diffusa **sensibilità ambientale** ed una **maggiore consapevolezza** sulle conseguenze dannose di alcuni aspetti ambientali diretti (come le emissioni ed i rifiuti) ed indiretti (come le contaminazioni alimentari);
- promuovere **stili di vit**a più salubri, riducendo cofattori di rischio come i comportamenti a rischio auto-lesivi (fumo, alcool, disordini alimentari, sedentarietà).

I ***principi*** che dovrebbero ispirare e sostenere le politiche dei servizi erogati a contenimento del rischio sanitario di origine ambientale **diretta** (per contatto, respirazione, ingestione accidentale) o **indiretta** (per contaminazioni della catena alimentare) dovrebbero essere i seguenti:

- sviluppo (realmente) **sostenibile**;
- coscienza della necessità di lasciare un'**eredità accettabile** alle future generazioni (un territorio che sia ancora utilizzabile, che non sia inquinato, etc);
- **contabilizzazione** del **danno** ambientale e correlato danno sanitario nei processi economici – introduzione delle valutazioni ambientali nelle stime di convenienza industriali;
- rispetto della salute **della popolazione prossima** ai luoghi di produzione (impatto sanitario di produzioni d'area – cfr. polveri sottili, inquinanti, epidemiologia);
- rispetto della salute presente e futura di tutta la popolazione umana (impatto globale, cfr. effetto serra, cfc, contaminazioni diffuse, etc);
- rispetto della salute **dei lavoratori** (malattie professionali - igienistica);
- rispetto della **propria** salute (stili di vita – comportamenti a rischio);
- maturazione nei cittadini di una **consapevolezza autonoma** in merito a **fattori di rischio sanitari "diretti"** di origine ambientale;
- maturazione nei cittadini di una **consapevolezza autonoma** in merito a **fattori di rischio sanitari "indiretti"** connessi a trattamenti industriali dei cibi e nelle catene produttive alimentari.

Verifica: **dalle informazioni raccolte attraverso famiglie ed associa-**

zioni nel nostro territorio quali servizi esistono che si ispirano ai principi sopra enumerati? Esistono servizi di eccellenza e quali? Quali le criticità? Quali miglioramenti proporre?

La verifica comporta anche la risposta ai seguenti interrogativi:

- Attività di formazione sugli strumenti di **analisi epidemiologica** (analisi statistiche, comprensione delle indagini, visione di dati recenti), **analisi tossicologica** (relazioni scientificamente attestate causa-effetto tra fattori ambientali/alimentari ed effetti sanitari, ed introduzione alla **medicina preventiva**?
- Attività educativa territoriale rivolta a:
  1. **lavoratori** (tutela, prevenzione del rischio, consapevolezza)?
  2. **famiglie** (cibo, conservazione, preparazione; comportamenti ed eco-sostenibilità)?
  3. **scuole** (stili di vita, comportamenti a rischio, eco sostenibilità)?
  4. **gestori** di strutture pubbliche e/o private (fattori di rischio ambientale per la salute, strumenti e processi per la riduzione dell'impatto e per un miglioramento della sostenibilità complessiva delle strutture gestite)?